

Exposición gradual — Guía clínica del protocolo

Fundamento, construcción de jerarquía y errores frecuentes

La exposición gradual es la intervención con mayor respaldo empírico para trastornos de ansiedad. Se basa en un principio simple: la evitación mantiene el miedo; el contacto sostenido con el estímulo temido, sin escape, permite que el miedo se reduzca naturalmente.

POR QUÉ FUNCIONA

La evitación da alivio inmediato pero refuerza la creencia de que la situación era peligrosa y de que solo evitando se sobrevive. La exposición rompe ese aprendizaje: permite habituación fisiológica y nueva evidencia de que el resultado temido no ocurre (o es manejable si ocurre).

CÓMO CONSTRUIR LA JERARQUÍA

- 1 Listar junto al paciente todas las situaciones evitadas relacionadas al cuadro.
- 2 Puntuar cada una de 0 a 10 según el nivel de ansiedad anticipada.
- 3 Ordenar de menor a mayor dificultad — no es necesario que sea lineal perfecto.
- 4 Elegir el primer escalón con ansiedad moderada (4-6/10): ni trivial ni abrumador.
- 5 Planificar frecuencia: exposiciones repetidas y cercanas en el tiempo superan a las espaciadas.

CRITERIOS DE PROGRESO

Avanzar al siguiente escalón cuando la ansiedad anticipada baja de forma sostenida (no necesariamente a 0) en el escalón actual, en al menos 2-3 repeticiones. No es necesario llegar a ansiedad cero para avanzar.

ERRORES COMUNES A EVITAR

- X Permitir conductas de seguridad encubiertas (distrarse, llevar medicación 'por si', X revisar el celular) — reducen el aprendizaje aunque el paciente no escape físicamente.
- X Avanzar demasiado rápido, generando una experiencia abrumadora que refuerza el miedo.
- X Terminar la exposición justo en el pico de ansiedad en lugar de esperar el descenso natural.

■ Clave clínica

Distinguir escape (abandonar la situación por ansiedad) de salida planificada (terminar la exposición tras cumplir el tiempo/objetivo acordado). El escape refuerza el miedo; la salida planificada no.